止血带 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：60 s · 出血肢体模型、两条商用止血带、脉搏模拟、计时笔

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 指出喷射/持续出血并立即选择商用止血带。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 在皮肤上伤口近端非关节处放置并说明选用体系距离。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 收紧至出血停止且触查远端脉搏消失。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 第一条无效时加第二条并再次核查两个效果。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 外露写明时间并交接转换三条件及禁忌。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：仍出血或仍有远端脉搏却宣布成功

反馈与下一轮改进：_____

来源：TCCC 2024, 中国院前共识2026, 中国休克共识2023

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

球囊面罩通气 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：120 s · 气道模拟人、双人面罩、氧源、储氧袋、监护

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 连接氧源与储氧袋，核查气流和监护。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 在SMR条件下托下颌并清除可见分泌物。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 与助手形成双手密闭，口头确认胸廓起伏。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 按成人约10次/分缓慢给气，不挤至过度胸廓膨胀。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 发现漏气/无胸廓起伏即调整并说明高级气道升级。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：无胸廓起伏仍持续无效通气

反馈与下一轮改进：_____

来源：BTS 成人急救氧疗指南（2017）, RCUK 特殊情况复苏指南（2025）, NICE NG41, AHA成人BLS2025

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

创伤插管 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：240 s · 视频喉镜、气道模型、吸引、备用SGA、CO_2、复苏道具

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 点名气道/助手/监护，启动低压复苏和预氧合。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 试吸引、视频喉镜、球囊与备用SGA并说明失败计划。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 说明减量滴定与SMR，在模型记录一次尝试及改进。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 低氧/失败时停止尝试恢复氧合，说明3+1上限。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 观察持续CO_2波形、固定导管并复查血压和深度。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：未持续波形$EtCO_2$确认却宣布成功

反馈与下一轮改进：_____

来源：DAS困难插管2025, JTS创伤麻醉2021/2023, NICE NG41

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

紧急颈前气道 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：180 s · 颈前气道训练器、#10刀、bougie、6.0套囊管、CO_2

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 明确宣告CICO、呼救并持续给氧。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 列出#10、bougie、6.0管并辨认训练器环甲膜。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 在模型完成纵切、辨膜、横刺及90°转刀。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 控制bougie进入深度并导引套囊管，避免暴力。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 充囊、通气、持续波形CO_2确认并固定。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：CICO后仍等待而未启动受训者救援，或未查波形

反馈与下一轮改进：_____

来源：DAS困难插管2025, NICE NG41

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

针刺胸部减压 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：120 s · 胸壁模型、两部位标记、14G/10G长导管、监护

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 结合单侧呼吸音和休克宣告疑张力威胁。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 在模型标正确侧和第4/5肋间腋中线前位置。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 选择长14G/10G导管，演示肋上缘方向。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 减压后比较呼吸氧合灌注，不以嘶声单独结束。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 无效时说明新导管替代部位及手指/胸管救援。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：减压侧别/部位错误或不稳定等待CT

反馈与下一轮改进：_____

来源：TCCC 2024, 中国院前共识2026, NICE NG39, WSES-AAST胸部2025

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

胸腔引流 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：300 s · 胸壁训练器、大小胸管/猪尾、水封、固定物、输出量模拟

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 口头核对正确侧、适应证及无菌/镇痛准备。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 定位安全三角并在训练器钝性入胸膜。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 按稳定性选择管径并确保所有侧孔入腔。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 连接水封、固定导管、记录初量与呼吸效果。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 报告小时量和持续休克，说明外科升级条件。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：错误侧别/部位或不连接引流系统

反馈与下一轮改进：_____

来源：WSES-AAST胸部2025, EAST血胸2021, NICE NG39

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

EFAST · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：240 s · 超声模拟器、腹/心包/双胸图像、标准窗清单

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 按左右上腹及盆腔三窗保存代表图像。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 保存剑突下心包窗并描述是否受限。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 比较双胸膜滑动与积液。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 报告阳性/阴性/受限窗口及时间而不越界推断。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 按不稳定性提出止血/重复/CT路径并说明阴性限制。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：以阴性FAST宣布排除所有出血

反馈与下一轮改进：_____

来源：NICE NG39, RCH：儿童重大创伤初评, WSES骨盆2017

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

骨盆束带 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：90 s · 骨盆模型、束带、大转子标志、皮肤风险卡

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 指出疑骨盆出血并避免重复挤压。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 双侧触认大转子并标中心线。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 说明伴伤禁忌后适当并膝内旋。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 将束带放至大转子水平并按装置收紧。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 复查皮肤/灌注、记录时间并交接替代固定计划。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：束带位于髂嵴/腰部仍宣布正确

反馈与下一轮改进：_____

来源：WSES骨盆2017, NICE NG37, 中国休克共识2023

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。

四肢临时固定 · OSCE

学员：_____ 教师：_____ 日期：_____

模拟限时：240 s · 肢体模型、夹板、盐水敷料、环形绷带、神经血管卡

0 未做/不安全；1 提示后完成；2 独立完成；满分10；关键失败否决。

1. 固定前逐项记录感觉运动及脉搏，标出开放创面。

□0 □1 □2 行为证据：_____

2. 为开放伤覆盖湿敷加封闭层并说明抗生素时点。

□0 □1 □2 行为证据：_____

3. 选择装置时检查骨盆和同侧膝踝牵引禁忌。

□0 □1 □2 行为证据：_____

4. 衬垫固定相邻关节后与基线比较神经血管。

□0 □1 □2 行为证据：_____

5. 疼痛进行性增加即松解环形层、置心脏水平并升级。

□0 □1 □2 行为证据：_____

合计：____ / 10 关键失败：固定后不复查神经血管或明显恶化仍加紧

反馈与下一轮改进：_____

来源：NICE NG37, NICE NG41

以本院规范为准；监督下模型训练，评分不替代真实操作授权。